Examen Tipo Test - OpoGen

Número de preguntas: 10

1. En relación con los ingresos programados en UCI y la acogida de la familia, el protocolo contempla:

A) Prohibir cualquier visita previa al ingreso para evitar interferencias en la organización de la unidad.

B) Permitir visitas previas al ingreso con el fin de minimizar el estrés que genera el ingreso en la unidad.

C) Autorizar visitas previas únicamente cuando el paciente lo solicite por escrito.

D) Sustituir las visitas previas por material informativo entregado a la familia.

2. Conforme al protocolo de acogida en UCI, ¿en qué supuesto se justifica la aplicación de barreras de protección individual a los familiares visitantes?

A) De forma generalizada durante toda la estancia, para minimizar el riesgo de infecciones cruzadas.

B) Únicamente cuando el paciente presente infección por microorganismos con mecanismos de resistencia, como KPC, para asegurar el aislamiento de contacto.

C) Siempre que el familiar solicite acompañar al paciente durante un procedimiento invasivo.

D) Cuando el paciente se encuentre incapacitado y la familia deba participar en la toma de decisiones.

3. Respecto a la lactancia materna en unidades de críticos pediátricos y neonatales, el protocolo establece que:

A) Se permitirá con carácter general, sin necesidad de valorar las condiciones del lactante ni de la madre.

B) Se permitirá exclusivamente en UCIN, quedando excluida en las UCIP.

C) Se permitirá siempre que las condiciones del lactante y de la madre sean adecuadas.

D) Quedará supeditada a la autorización expresa del facultativo responsable del ingreso.

4. Según el texto, ¿qué efecto concreto se llega a asegurar por algunos autores en relación con la cercanía de un ser querido al paciente en UCI?

A) La reducción de la estancia media en la unidad de cuidados intensivos.

B) La mejora de la actividad cardíaca de los pacientes.

C) La disminución de la necesidad de sedación farmacológica.

D) La reducción de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria.

5. ¿Qué experiencia previa se invoca en el texto como fundamento para plantear la adaptación del modelo de puertas abiertas a las UCI de adultos?

A) La de las Unidades de Cuidados Intensivos pediátricas y neonatales, donde la familia se considera pilar fundamental del cuidado íntegro.

B) La de las unidades de hospitalización convencional, donde la visita se flexibilizó sin incidencias reseñables.

C) La de los servicios de urgencias, que ya aplicaban horarios de visita ampliados con resultados positivos.

D) La de las unidades de cuidados paliativos, donde la familia participa en los cuidados desde hace décadas.

6. Según el texto, ¿cuál fue el verdadero motivo por el que el modelo restrictivo de visitas en UCI se mantuvo implantado durante tanto tiempo?

A) La evidencia científica demostraba que perjudicaba la seguridad del paciente.

B) La costumbre y la falta de crítica sobre los inconvenientes de dicho modelo.

C) La limitada estructura del box y la vulneración de la intimidad de otros pacientes.

D) La mayor dificultad para realizar los cuidados enfermeros que generaba en los profesionales.

7. En materia de participación de los familiares en los cuidados del paciente crítico, ¿cuál de las siguientes actuaciones se contempla expresamente en el protocolo?

A) Imponer la implicación de la familia en los cuidados, con independencia de su voluntad.

B) Valorar la estructura familiar para identificar potenciales cuidadores, siempre que estos lo deseen.

C) Limitar la formación de los familiares a los aspectos meramente informativos del ingreso.

D) Reservar la participación familiar exclusivamente a los ingresos no programados.

8. Cuando el paciente crítico se encuentra incapacitado, la toma de decisiones sobre el tratamiento o cualquier procedimiento debe:

A) Adoptarse de forma unilateral por el equipo sanitario, dada la urgencia vital.

B) Delegarse íntegramente en el familiar de mayor grado de parentesco.

C) Compartirse con la familia, apoyándose en herramientas validadas para la ayuda en la toma de decisiones.

D) Suspenderse hasta que el paciente recupere su capacidad de obrar.

9. Respecto a las barreras percibidas por los profesionales para flexibilizar los horarios en UCI, ¿qué afirma el texto que demuestra la evidencia?

A) Que dichas barreras se confirman y justifican el mantenimiento de las restricciones de visita.

B) Que solo la limitada estructura del box constituye un obstáculo real e insalvable.

C) Que la evidencia demuestra todo lo contrario, ya que las acciones que disminuyen el estrés favorecen la seguridad del paciente y su familia.

D) Que la mayor ansiedad familiar ante procedimientos invasivos es el único efecto adverso documentado.

10. ¿En qué guía de buenas prácticas se basan la mayoría de protocolos o Guías de Práctica Clínica para desarrollar sus objetivos y estrategias, según el texto?

A) En la guía de buenas prácticas del Plan HU-CI.

B) En las recomendaciones de la Sociedad Española de Medicina Intensiva.

C) En los protocolos de las Unidades de Cuidados Intensivos pediátricas y neonatales.

D) En las guías de práctica clínica de las unidades de hospitalización convencional.

Hoja de Respuestas Correctas

1. B
2. B
3. C
4. B
5. A
6. B
7. B
8. C
9. C
10. A